

des soucis dans l'anxiété généralisée, par l'éloignement de la maison ou d'une figure d'attachement dans l'anxiété de séparation) et ne remplissent donc pas les critères d'un trouble panique. (**N.B.** : Parfois une attaque de panique inattendue est associée au début d'un autre trouble anxieux mais les attaques deviennent ensuite attendues, alors que le trouble panique est caractérisé par des attaques de panique inattendues récurrentes.) Si les attaques de panique surviennent seulement en réponse à des déclencheurs spécifiques, alors seul le diagnostic du trouble anxieux pertinent est retenu. Cependant, si un individu éprouve aussi des attaques de panique inattendues et présente des inquiétudes ou des changements de comportement à cause des attaques, un diagnostic additionnel de trouble panique doit être considéré.

Comorbidité

Le trouble panique ne survient pas fréquemment dans des contextes cliniques en l'absence d'autres manifestations psychopathologiques. La prévalence du trouble panique est élevée chez les personnes qui présentent d'autres troubles, en particulier un autre trouble anxieux (surtout une agoraphobie), un trouble dépressif caractérisé ou bipolaire, et éventuellement un trouble léger de l'usage d'alcool ([Kessler et al. 2005b](#)). Alors que le trouble panique a un âge de début plus précoce que les troubles comorbides, le début survient parfois après le trouble comorbide, ce qui peut être vu comme un marqueur de sévérité du trouble comorbide.

Les taux de comorbidité sur la vie entière entre le trouble dépressif caractérisé et le trouble panique varient de façon importante, allant de 10 à 65 % chez les personnes souffrant de trouble panique. Chez approximativement un tiers des personnes souffrant des deux maladies, la dépression précède le début du trouble panique. Dans les deux tiers restants, la dépression survient de façon concomitante ou suit le début du trouble panique. Un sous-groupe de personnes souffrant de trouble panique développe un trouble lié à une substance, qui pour certains représente une tentative de traiter leur anxiété avec de l'alcool ou des médicaments ([Zimmermann et al. 2003](#)). La comorbidité avec d'autres troubles anxieux et avec la crainte excessive d'avoir une maladie est également fréquente.

Le trouble panique est significativement comorbide avec de nombreux symptômes et affections médicales générales, incluant entre autres les vertiges, l'arythmie cardiaque, l'hyperthyroïdie, l'asthme, la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) et le syndrome du côlon irritable. Cependant, la nature de l'association (p. ex. cause et effet) entre le trouble panique et ces affections reste incertaine. Bien que le prolapsus de la valve mitrale et les troubles thyroïdiens soient plus fréquents parmi les personnes souffrant de trouble panique que dans la population générale, les différences de prévalence ne sont pas systématiques.

Spécification de l'attaque de panique

N.B. : Les symptômes sont présentés dans le but d'identifier une attaque de panique ; toutefois, une attaque de panique n'est pas un trouble mental et ne peut pas être codée. Les attaques de panique peuvent survenir dans le contexte de n'importe quel trouble anxieux ainsi que dans d'autres troubles mentaux (p. ex. troubles dépressifs, trouble stress post-traumatique, troubles de l'usage d'une substance) et dans certaines affections médicales (p. ex. cardiaques, respiratoires, vestibulaires, gastro-intestinales). Quand la présence d'une attaque de panique est identifiée, elle doit être notée comme une spécification (p. ex. « trouble stress post-traumatique avec attaques de panique »). Pour le trouble panique, la

présence d'une attaque de panique fait partie des critères du trouble et n'est pas utilisée comme spécification.

Une montée brusque de crainte intense ou de malaise intense qui atteint son acmé en quelques minutes, avec la survenue de quatre (ou plus) des symptômes suivants :

N.B. : La montée brusque peut survenir durant un état de calme ou d'anxiété.

1. Palpitations, battements de cœur ou accélération du rythme cardiaque.
2. Transpiration.
3. Tremblements ou secousses musculaires.
4. Sensations de « souffle coupé » ou impression d'étouffement.
5. Sensation d'étranglement.
6. Douleur ou gêne thoracique.
7. Nausée ou gêne abdominale.
8. Sensation de vertige, d'instabilité, de tête vide ou impression d'évanouissement.
9. Frissons ou bouffées de chaleur.
10. Paresthésies (sensations d'engourdissement ou de picotements).
11. Déréalisation (sentiments d'irréalité) ou dépersonnalisation (être détaché de soi).
12. Peur de perdre le contrôle de soi ou de « devenir fou ».
13. Peur de mourir.

N.B. : Des symptômes en lien avec la culture (p. ex. acouphènes, douleur au cou, céphalée, cris ou pleurs incontrôlables) peuvent être observés. De tels symptômes ne peuvent pas compter pour l'un des quatre symptômes requis.

Caractéristiques

La caractéristique essentielle d'une attaque de panique est une montée brusque de crainte intense ou de malaise intense qui atteint son acmé en quelques minutes, durant laquelle quatre ou plus des 13 symptômes physiques ou cognitifs surviennent. Onze de ces 13 symptômes sont physiques (p. ex. palpitations, transpiration), tandis que deux sont cognitifs (c.-à-d. la peur de perdre le contrôle ou de devenir fou, la peur de mourir). « La peur de devenir fou » est une expression familière souvent utilisée par les personnes souffrant d'attaques de panique et n'est pas à retenir comme un terme péjoratif ou diagnostique. Le terme *en quelques minutes* signifie que le temps pour atteindre le pic d'intensité n'est littéralement que de quelques minutes. Une attaque de panique peut survenir dans un état de calme ou dans un état d'anxiété, et le temps pour atteindre le pic d'intensité doit être évalué indépendamment quel que soit l'état d'anxiété antérieur. C'est-à-dire que le début d'une attaque de panique est le point à partir duquel il y a une augmentation abrupte d'inconfort plutôt que le point à partir duquel l'anxiété a commencé à se développer. De même, une attaque de panique peut revenir soit vers un état anxieux soit vers un état calme, et éventuellement croître à nouveau en intensité. Une attaque de panique est distinguée d'une anxiété progressive par le temps mis pour atteindre le pic d'anxiété, lequel survient en quelques minutes, par sa nature discontinue et par son intensité généralement plus sévère. Les attaques qui remplissent tous les autres critères mais ont moins de quatre symptômes physiques et/ou cognitifs sont appelées *attaques paucisymptomatiques*.

Il existe deux types d'attaques de panique caractéristiques : attendues ou inattendues. Les *attaques de panique attendues* sont des attaques pour lesquelles il y a un déclencheur ou un repère évident, tel que des situations dans lesquelles des attaques de panique sont survenues de façon typique. Les attaques de panique inattendues sont celles pour lesquelles il n'y a pas de déclencheur ou de repère évident au moment de la survenue

(p. ex. pendant un moment de détente ou pendant le sommeil [attaque de panique nocturne]). La détermination du caractère attendu ou inattendu de l'attaque de panique est faite par le clinicien, qui fonde son jugement sur une combinaison entre un interrogatoire minutieux sur la séquence d'événements qui a précédé ou conduit à l'attaque et le jugement propre de la personne sur le fait ou non que l'attaque semble survenir en l'absence de raison apparente. Les interprétations culturelles peuvent influencer la détermination du caractère attendu ou inattendu. Des symptômes spécifiques à la culture (p. ex. acouphènes, douleurs au cou, céphalées, cris ou pleurs incontrôlables) peuvent être observés ; cependant, de tels symptômes ne peuvent être pris en compte pour un des quatre symptômes requis. Les attaques de panique peuvent survenir dans n'importe quel contexte de trouble mental (p. ex. troubles anxieux, troubles dépressifs, troubles bipolaires, troubles des conduites alimentaires, troubles obsessionnels-compulsifs et apparentés, troubles de la personnalité, troubles psychotiques, troubles de l'usage d'une substance) et certaines affections médicales (p. ex. cardiaques, respiratoires, vestibulaires, gastro-intestinales) mais ne remplissent que rarement les critères d'un trouble panique (Kessler et al. 2005). Des attaques de panique inattendues récurrentes sont nécessaires pour un diagnostic de trouble panique.

Caractéristiques associées

Un type d'attaque de panique inattendue est l'attaque de panique nocturne (c.-à-d. se réveiller dans un état de panique), ce qui diffère de paniquer après être complètement réveillé. Les attaques de panique sont associées à un risque accru de tentative de suicide et d'idées suicidaires même quand les comorbidités et les autres facteurs de risque de suicide sont pris en compte (Craske et al. 2010).

Prévalence

En population générale, l'estimation de la prévalence sur 12 mois pour les attaques de panique aux États-Unis est de 11,2 % chez les adultes (Kessler et al. 2006). L'estimation de la prévalence sur 12 mois ne diffère pas significativement parmi les Afro-Américains, les Américains (Lewis-Fernández et al. 2010) d'origine asiatique, et les Latino-Américains. Des estimations plus basses de la prévalence sur 12 mois pour les pays européens vont de 2,7 à 3,3 % (Fullana et al. 2011 ; Lewis-Fernández et al. 2010). Les femmes sont plus fréquemment affectées que les hommes, bien que cette différence entre les genres soit plus prononcée pour le trouble panique (Kessler et al. 2005). Les attaques de panique peuvent survenir chez les enfants mais sont relativement rares jusqu'à l'âge de la puberté, quand les taux de prévalence augmentent (Craske et al. 2010). Les taux de prévalence décroissent chez les personnes âgées, reflétant possiblement une diminution de la sévérité à des niveaux infracliniques (Kessler et al. 2005 ; Wolitzky-Taylor et al. 2010).

Développement et évolution

L'âge moyen de début des attaques de panique aux États-Unis est d'environ 22-23 ans chez les adultes (Kessler et al. 2005). Cependant, l'évolution des attaques de panique est surtout influencée par l'évolution de troubles mentaux concomitants et des événements de vie stressants. Les attaques de panique sont inhabituelles, et les attaques de panique inattendues sont rares chez les enfants avant l'adolescence (Craske et al. 2010). Les adolescents peuvent être moins enclins que les adultes à discuter ouvertement des attaques de panique, même quand ils présentent des épisodes de peur ou d'inconfort intense. La prévalence plus basse d'attaques de panique chez les personnes âgées peut être liée à une réponse plus faible du système nerveux autonome aux états émotionnels que chez les

jeunes (Mohlman et al. 2012). Les personnes âgées peuvent être moins enclines à utiliser le mot « peur » et plus à même d'utiliser le mot « inconfort » pour décrire les attaques de panique (Wolitzky-Taylor et al. 2010). Les personnes âgées avec « une sensation de panique » peuvent avoir un mélange d'attaques paucisymptomatiques et d'anxiété généralisée. De plus, les personnes âgées ont tendance à imputer les attaques de panique à certaines situations qui sont stressantes (p. ex. examens médicaux, contexte social) et peuvent rétrospectivement trouver des explications pour les attaques de panique même si, sur le moment, cela était inattendu. Cela peut avoir comme conséquence une sous-reconnaissance des attaques de panique inattendues chez les personnes âgées.

Facteurs de risque et pronostiques

Tempéramentaux. L'affectivité négative (névrosisme) (c.-à-d. la tendance à vivre des émotions négatives) et une sensibilité à l'anxiété (c.-à-d. la disposition à croire que les symptômes d'anxiété sont dangereux) sont des facteurs de risque pour la survenue des attaques de panique (Craske et al. 2010). Des antécédents de « bouffées d'angoisse » (c.-à-d. des attaques paucisymptomatiques qui ne répondent pas aux critères d'une attaque de panique complète) peuvent être un facteur de risque pour développer des attaques de panique (Craske et al. 2010).

Environnementaux. Fumer est un facteur de risque d'attaques de panique (Isensee et al. 2003). La plupart des individus rapportent des facteurs de stress identifiables dans les mois précédant leur première attaque de panique (p. ex. des facteurs de stress interpersonnels et des facteurs de stress liés au bien-être physique, tels que des expériences négatives avec des drogues illicites ou des médicaments, ou un décès dans la famille).

Questions diagnostiques liées à la culture

Les interprétations culturelles peuvent influencer la détermination du caractère attendu ou inattendu des attaques de panique. On peut observer des symptômes culturels spécifiques (p. ex. acouphènes, douleurs au cou, céphalées, cris ou pleurs incontrôlables) ; cependant, de tels symptômes ne doivent pas être pris en compte pour l'un des quatre symptômes requis. La fréquence de chacun des 13 symptômes varie selon les cultures (p. ex. des taux plus élevés de paresthésies chez les Afro-Américains et de sensations vertigineuses dans plusieurs groupes asiatiques) (Lewis-Fernández et al. 2010). Les syndromes culturels influencent aussi la présentation transculturelle des attaques de panique ; il en résulte différents profils symptomatologiques parmi les différents groupes culturels. Les exemples incluent les attaques *khyâl* (vent), un syndrome culturel cambodgien comprenant vertiges, acouphènes et douleur au cou, et les attaques *trúng gió* (liées au vent), un syndrome culturel vietnamien associé à des maux de tête. *Lataque de nervios* (attaque de nerfs) est un syndrome culturel chez les Américains d'Amérique latine qui peut inclure des tremblements, des cris ou pleurs incontrôlés, des comportements agressifs ou suicidaires, et une dépersonnalisation ou déréalisation, et qui peut être vécu plus longtemps que quelques minutes (Lewis-Fernández et al. 2010). Certaines présentations cliniques d'attaque de nervios remplissent les critères pour des pathologies différentes des attaques de panique (p. ex. autre trouble dissociatif). En outre, les attentes culturelles peuvent influencer la classification d'attaques de panique comme attendues ou inattendues, de même que les syndromes culturels peuvent créer des peurs de certaines situations, allant du champ des relations interpersonnelles (associées aux *ataque de nervios*) à des types d'effort (associés aux attaques *khyâl*), aux vents atmosphériques (associés aux attaques *trúng gió*). (Craske et al. 2010) Pour plus d'informations sur les syndromes culturels, se référer au « Glossaire des concepts culturels de détresse » en annexe.

Questions diagnostiques liées au genre

Les attaques de panique sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes mais les signes cliniques ou les symptômes ne diffèrent pas entre les hommes et les femmes.

Marqueurs diagnostiques

Les enregistrements physiologiques d'attaques de panique survenant naturellement chez des individus avec un trouble panique indiquent une montée brusque de l'éveil, et généralement de la fréquence cardiaque, qui atteint un pic en quelques minutes et disparaît en quelques minutes (Craske et al. 2010), et pour une partie de ces individus l'attaque de panique peut être précédée par des instabilités cardiorespiratoires (Meuret and Ritz 2010).

Retentissement fonctionnel des attaques de panique

Dans le contexte de troubles mentaux concomitants, incluant les troubles anxieux, les troubles dépressifs, le trouble bipolaire, les troubles de l'usage d'une substance, les troubles psychotiques et les troubles de la personnalité, les attaques de panique sont associées à une sévérité accrue des symptômes, un taux plus élevé de comorbidité et de suicidalité, et une plus mauvaise réponse au traitement. De plus, les attaques de panique complètes sont associées typiquement à une morbidité plus importante (p. ex. recours aux soins plus important, plus de handicap, moins bonne qualité de vie) que les attaques paucisymptomatiques (Craske et al. 2010).

Diagnostic différentiel

Autres épisodes paroxystiques (p. ex. « attaques de colère »). On ne doit pas faire un diagnostic d'attaques de panique si les épisodes n'incluent pas la caractéristique essentielle d'une montée brusque de peur intense ou d'intense inconfort, mais plutôt celui d'un autre état émotionnel (p. ex. colère, chagrin).

Trouble anxieux lié à une autre affection médicale. Les affections médicales qui peuvent causer ou être diagnostiquées à tort comme attaques de panique incluent l'hyperthyroïdie, l'hyperparathyroïdie, le phéochromocytome, les dysfonctionnements vestibulaires, l'épilepsie et les affections cardiopulmonaires (p. ex. arythmies, tachycardie supraventriculaire, asthme, BPCO). Des tests de laboratoire appropriés (p. ex. calcémie pour l'hyperparathyroïdie, ECG avec moniteur Holter pour les arythmies) ou des examens physiques (p. ex. pour les affections cardiaques) peuvent être utiles pour déterminer le caractère étiologique d'une autre affection médicale.

Trouble anxieux induit par une substance/un médicament. Une intoxication par des psychostimulants du système nerveux central (p. ex. cocaïne, amphétamines, caféine) ou par le cannabis ou le sevrage d'un dépresseur du système nerveux central (p. ex. alcool, barbituriques) peuvent précipiter une attaque de panique. Une anamnèse détaillée doit être recueillie pour déterminer si la personne avait des attaques de panique avant l'usage excessif d'une substance. Les caractéristiques comme un âge de début après 45 ans ou la présence de symptômes atypiques durant une attaque de panique (p. ex. vertige, perte de conscience, perte d'urine ou de selles, propos incohérents ou amnésie) suggèrent la possibilité qu'une affection médicale ou une substance puisse être à l'origine des symptômes d'attaque de panique.

Trouble panique. La répétition d'attaques de panique inattendues est requise mais pas suffisante pour le diagnostic de trouble panique (c.-à-d. que les critères pour le diagnostic de trouble panique doivent être entièrement remplis).

Comorbidité

Les attaques de panique sont associées à une probabilité accrue de divers troubles mentaux comorbides, incluant les troubles anxieux, les troubles dépressifs, les troubles bipolaires, les troubles du contrôle des impulsions, les troubles de l'usage d'une substance (Kessler et al. 2005). Les attaques de panique sont associées à une probabilité accrue de développer ultérieurement des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des troubles bipolaires et potentiellement d'autres troubles (Craske et al. 2010).

Agoraphobie

Critères diagnostiques

300.22 (F40.00)

- A. Peur ou anxiété marquées pour deux (ou plus) des cinq situations suivantes :
 1. Utiliser les transports en commun (p. ex. voitures, bus, trains, bateaux, avions).
 2. Être dans des endroits ouverts (p. ex. parking, marchés, ponts).
 3. Être dans des endroits clos (p. ex. magasins, théâtres, cinémas).
 4. Être dans une file d'attente ou dans une foule.
 5. Être seul à l'extérieur du domicile.
- B. La personne craint ou évite ces situations parce qu'elle pense qu'il pourrait être difficile de s'en échapper ou de trouver du secours en cas de survenue de symptômes de panique ou d'autres symptômes incapacitants ou embarrassants (p. ex. peur de tomber chez les personnes âgées, peur d'une incontinence).
- C. Les situations agoraphobogènes provoquent presque toujours une peur ou de l'anxiété.
- D. Les situations agoraphobogènes sont activement évitées, nécessitent la présence d'un accompagnant, ou sont subies avec une peur intense ou de l'anxiété.
- E. La peur ou l'anxiété sont disproportionnées par rapport au danger réel lié aux situations agoraphobogènes et compte tenu du contexte socioculturel.
- F. La peur, l'anxiété ou l'évitement sont persistants, durant typiquement 6 mois ou plus.
- G. La peur, l'anxiété ou l'évitement causent une détresse ou une altération cliniquement significative du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.
- H. Si une autre affection médicale (p. ex. maladie inflammatoire de l'intestin, maladie de Parkinson) est présente, la peur, l'anxiété ou l'évitement sont clairement excessifs.
- I. La peur, l'anxiété ou l'évitement ne sont pas mieux expliqués par les symptômes d'un autre trouble mental ; par exemple, les symptômes ne sont pas limités à une phobie spécifique, de type situationnel, ne sont pas uniquement présents dans des situations sociales (comme dans l'anxiété sociale) et ne sont pas liés exclusivement à des obsessions (comme dans le trouble obsessionnel-compulsif), à des perceptions de défauts ou d'imperfections dans l'apparence physique (comme dans l'obsession d'une dysmorphie corporelle), à des rappels d'événements traumatiques (comme dans le trouble stress post-traumatique) ou à une peur de la séparation (comme dans l'anxiété de séparation).

N.B. : L'agoraphobie est diagnostiquée indépendamment de la présence d'un trouble panique. Si la présentation clinique d'une personne remplit les critères pour un trouble panique et une agoraphobie, les deux diagnostics doivent être retenus.

Caractéristiques diagnostiques

La caractéristique essentielle de l'agoraphobie est une peur ou une anxiété marquée, ou intense déclenchée par une exposition réelle ou anticipée à des situations variées (critère A). Le diagnostic requiert la présence de symptômes survenant dans au moins deux des cinq situations suivantes : 1) utiliser les transports publics, comme les voitures,

bus, trains, bateaux ou avions ; 2) être dans des endroits ouverts comme des parkings, marchés ou ponts ; 3) être dans des endroits clos comme des boutiques, théâtres ou cinémas ; 4) être dans une file d'attente ou dans une foule ; ou 5) être seul à l'extérieur du domicile. Les exemples pour chaque situation ne sont pas exhaustifs ; d'autres situations peuvent être craintes (Wittchen et al. 2010). Quand elles ressentent de la peur ou de l'anxiété déclenchées par de telles situations, les personnes pensent généralement que quelque chose de terrible pourrait arriver (critère B). Elles croient fréquemment qu'il pourrait être difficile de s'échapper de telles situations (p. ex. « je ne peux pas sortir d'ici ») ou qu'elles ne pourraient pas trouver du secours (p. ex. « il n'y a personne pour m'aider ») quand les symptômes de type panique ou d'autres symptômes embarrassants ou invalidants surviennent. Les « symptômes de type panique » renvoient à n'importe lequel des 13 symptômes inclus dans les critères pour l'attaque de panique, comme l'étourdissement, l'évanouissement ou la peur de mourir. Les « autres symptômes embarrassants ou invalidants » incluent des symptômes comme des vomissements ou des symptômes du côlon irritable, ainsi que, chez les personnes âgées, la peur de tomber ou, chez les enfants, une sensation de désorientation ou d'être perdu.

L'importance de la peur éprouvée peut varier en fonction de la proximité de la situation crainte et survenir dans l'anticipation ou en présence de la situation agoraphobogène. De plus, la peur ou l'anxiété peuvent prendre la forme d'attaque de panique complète ou paucisymptomatique (c.-à-d. une attaque de panique attendue). La peur ou l'anxiété est évoquée presque à chaque fois que la personne se trouve dans la situation crainte (critère C). Ainsi, une personne qui devient anxieuse seulement occasionnellement dans une situation agoraphobogène (p. ex. devient anxieuse en étant dans une file d'attente seulement une fois sur cinq) ne recevra pas un diagnostic d'agoraphobie (Craske et al. 2010 ; Wittchen et al. 2010). La personne évite activement la situation ou, si elle ne peut pas ou décide de ne pas l'éviter, la situation génère une peur ou une anxiété intense (critère D). *L'évitement actif* signifie que la personne adopte à ce moment-là des comportements qui sont intentionnellement destinés à prévenir ou réduire le contact avec les situations agoraphobogènes. L'évitement peut être de nature comportementale (p. ex. changer ses routines quotidiennes, choisir un travail proche pour éviter d'utiliser les transports publics, se faire livrer à domicile les courses pour éviter les magasins et les supermarchés) ainsi que cognitive (p. ex. utiliser une distraction pour passer à travers une situation agoraphobogène). L'évitement peut devenir si sévère que la personne est complètement repliée à domicile. Souvent, une personne est plus à même de se confronter à une situation crainte quand elle est accompagnée par quelqu'un, par exemple un partenaire, un ami ou un professionnel de santé.

La peur, l'anxiété ou l'évitement doivent être disproportionnés par rapport au danger réel lié aux situations agoraphobogènes et compte tenu du contexte socioculturel (critère E). Différencier les peurs agoraphobogènes cliniquement significatives des peurs raisonnables (p. ex. quitter la maison durant un violent orage) ou des situations considérées comme dangereuses (p. ex. marcher dans un parking ou utiliser les transports publics dans une zone à forte criminalité) est important pour un certain nombre de raisons. Premièrement, ce qui constitue l'évitement peut être difficile à apprécier selon les cultures et les contextes socioculturels (p. ex. il est approprié socioculturellement pour les femmes musulmanes dans certaines parties du monde d'éviter de sortir de la maison seules, et ainsi un tel évitement ne sera pas considéré comme une agoraphobie). Deuxièmement, les personnes âgées sont susceptibles de surattribuer leurs peurs aux contraintes liées à l'âge et sont moins à même de juger leur peur disproportionnée par rapport au risque réel (Wolitzky-Taylor et al. 2010). Troisièmement, les personnes souffrant d'agoraphobie sont susceptibles de surestimer le danger lié aux symptômes de panique ou à d'autres symptômes corporels (Chambless et al. 1984 ; McNally et Lorenz 1987). On ne doit faire

un diagnostic d'agoraphobie que si la peur, l'anxiété ou l'évitement persistent (critère F) et causent une détresse ou une altération cliniquement significative du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants (critère G). La durée de « typiquement durant 6 mois ou plus » sert à exclure les personnes présentant des problèmes d'une durée courte ou transitoire. Cependant, le critère de durée doit être utilisé comme un guide général, avec la possibilité d'un certain degré de flexibilité.

Caractéristiques associées au diagnostic

Dans ses formes les plus sévères, l'agoraphobie peut imposer aux personnes un repli à domicile complet, les rendant incapables de quitter leur maison et dépendantes des autres pour des services ou de l'assistance y compris pour les besoins de base. La démoralisation et les symptômes dépressifs sont fréquents, ainsi que l'abus d'alcool et de médicaments sédatifs en tant que stratégies inappropriées d'automédication.

Prévalence

Chaque année approximativement 1,7 % des adolescents et des adultes reçoivent un diagnostic d'agoraphobie (Kessler et al. 2012 ; Wittchen et al. 2011). Les femmes sont deux fois plus à risque que les hommes pour l'agoraphobie (Wittchen et al. 2010). L'agoraphobie peut survenir dans l'enfance mais l'incidence atteint un maximum à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte (Beesdo et al. 2009 ; Bittner et al. 2007). La prévalence annuelle chez les personnes de plus de 65 ans est de 0,4 % (Kessler et al. 2006). Les taux de prévalence ne semblent pas varier systématiquement parmi les groupes culturels/ethniques (Gustavsson et al. 2011 ; Lewis-Fernández et al. 2010).

Développement et évolution

Le taux d'individus souffrant d'agoraphobie rapportant des attaques de panique ou un trouble panique précédant le début de l'agoraphobie varie de 30 % dans les échantillons de la communauté à plus de 50 % dans les échantillons cliniques. La majorité des individus souffrant de trouble panique montrent des signes d'anxiété et d'agoraphobie avant le début du trouble panique (Fava et al. 1992 ; Garvey et al. 1988).

Dans deux tiers de l'ensemble des cas d'agoraphobie, le début du trouble est avant 35 ans. Il y a un risque d'incidence important en fin d'adolescence et au début de l'âge adulte, avec des indications pour une deuxième phase de risque après l'âge de 40 ans. Une première apparition dans l'enfance est rare. L'âge moyen global d'apparition pour l'agoraphobie est de 17 ans, bien que l'âge d'apparition de l'agoraphobie sans attaques de panique ou sans trouble panique antérieur soit de 25-29 ans (Nocon et al. 2008 ; Wittchen et al. 2010).

L'évolution de l'agoraphobie est typiquement persistante et chronique. La rémission complète est rare (10 %), à moins que l'agoraphobie ne soit traitée (Emmelkamp et Wittchen 2009). Avec les agoraphobies plus graves, les taux de rémission complète décroissent, tandis que les taux de rechutes et de chronicité augmentent. Divers autres troubles, en particulier d'autres troubles anxieux, troubles dépressifs, troubles de l'usage d'une substance et troubles de la personnalité, peuvent compliquer l'évolution de l'agoraphobie. L'évolution sur le long terme et l'issue de l'agoraphobie sont associées à un risque élevé de trouble dépressif caractérisé secondaire, de trouble dépressif persistant (dysthymie) et de troubles de l'usage d'une substance.

Les caractéristiques cliniques sont relativement constantes au cours de la vie, bien que le type de situations agoraphobogènes déclenchant la peur, l'anxiété ou l'évitement, ainsi que le type de cognitions, puissent varier. Par exemple, chez les enfants, être à l'extérieur de la maison est la situation la plus crainte, tandis que chez les personnes

plus âgées, c'est être dans des magasins, dans une file d'attente et dans un endroit ouvert (Wittchen et al. 2010). De plus, les cognitions se rapportent souvent au fait d'être perdu (chez les enfants), de ressentir des symptômes de panique (chez les adultes), de tomber (chez les personnes âgées).

La prévalence basse chez les enfants pourrait refléter des difficultés à rapporter les symptômes, et ainsi l'évaluation des jeunes enfants peut nécessiter le recueil d'informations de multiples sources, incluant les parents et les enseignants (Beesdo et al. 2009). Les adolescents, particulièrement les garçons, peuvent être moins enclins que les adultes à discuter ouvertement des peurs agoraphobogènes et de l'évitement ; cependant, l'agoraphobie peut survenir avant l'âge adulte et doit être recherchée chez les enfants et les adolescents. Chez les personnes âgées, les troubles comorbides avec symptômes somatiques, ainsi que les perturbations motrices (p. ex. sensation de tomber ou d'avoir des complications médicales), sont fréquemment mentionnés pour expliquer leur peur ou l'évitement (McCabe et al. 2006). Dans ces circonstances, il faut évaluer avec soin si la peur ou l'évitement sont disproportionnés par rapport au danger réel encouru.

Facteurs de risque et pronostiques

Tempéramentaux. L'inhibition comportementale et une disposition névrotique (c.-à-d. une affectivité négative [névrosisme] et une sensibilité à l'anxiété) sont étroitement associées à l'agoraphobie mais elles le sont aussi pour la plupart des troubles anxieux (troubles phobiques, trouble panique, trouble anxieux généralisé) (Rohrbacher et al. 2008 ; Wittchen et al. 2010). La sensibilité à l'anxiété (la disposition à croire que les symptômes d'anxiété sont dangereux) est aussi caractéristique des individus souffrant d'agoraphobie (Hayward et Wilson 2007).

Environnementaux. Des événements négatifs durant l'enfance (p. ex. séparation, mort d'un parent) et d'autres événements stressants, comme être attaqué ou agressé, sont associés à l'apparition de l'agoraphobie. De plus, les personnes souffrant d'agoraphobie décrivent un climat familial et une éducation caractérisés par une chaleur réduite et une augmentation de la surprotection (Wittchen et al. 2010).

Génétiques et physiologiques. L'hérabilité pour l'agoraphobie est de 61 % (Kendler et al. 1999). Des différents types de phobie, l'agoraphobie a l'association la plus forte et la plus spécifique avec le facteur génétique que représente la prédisposition à des phobies (Kendler et al. 1992a ; Kendler et al. 1992b).

Questions diagnostiques liées au genre

Les femmes ont des patterns de troubles comorbides différents des hommes. En accord avec les différences de genre dans la prévalence des troubles mentaux, les hommes ont des taux plus élevés de troubles comorbides de l'usage d'une substance.

Retentissement fonctionnel de l'agoraphobie

L'agoraphobie est associée à un taux considérable de handicap et d'invalidité en termes de fonctionnement, de productivité au travail et de jours d'invalidité. La sévérité de l'agoraphobie est un déterminant fort du degré d'invalidité, indépendamment de la présence d'un trouble panique comorbide, d'attaques de panique et d'autres affections comorbides (Kessler et al. 2006 ; Wittchen et al. 2010). Plus du tiers des individus souffrant d'agoraphobie sont complètement repliés à domicile et incapables de travailler.

Diagnostic différentiel

Quand les critères diagnostiques pour l'agoraphobie et un autre trouble sont complètement remplis, les deux diagnostics doivent être retenus, à moins que la peur, l'anxiété

ou l'évitement de l'agoraphobie ne soient imputables à l'autre trouble. La pondération des critères et le jugement clinique peuvent être utiles dans certains cas.

Phobie spécifique, de type situationnel. Différencier l'agoraphobie d'une phobie spécifique situationnelle peut être difficile dans certains cas, du fait que ces deux affections partagent plusieurs symptômes caractéristiques et des critères. La phobie spécifique de type situationnel doit être diagnostiquée plutôt que l'agoraphobie si la peur, l'anxiété ou l'évitement sont limités à une des situations agoraphobogènes. La présence de peurs de deux situations agoraphobogènes ou plus est fort utile pour différencier l'agoraphobie des phobies spécifiques, particulièrement celle de type situationnel. D'autres caractéristiques de différenciation concernent l'idéation cognitive. Ainsi, si la situation est crainte pour des raisons autres que la présence de symptômes de type panique ou d'autres symptômes invalidants ou embarrassants (p. ex. la peur d'être directement blessé par la situation, comme la peur d'un accident d'avion pour les personnes qui ont peur de voler), un diagnostic de phobie spécifique est peut-être plus approprié.

Anxiété de séparation. L'anxiété de séparation peut être différenciée au mieux de l'agoraphobie à partir de l'idéation cognitive. Dans l'anxiété de séparation, les pensées concernent le détachement des personnes importantes et de l'environnement familial (c.-à-d. les parents ou les autres figures d'attachement), tandis que dans l'agoraphobie, le focus se porte sur les symptômes de type attaque de panique ou d'autres symptômes invalidants ou embarrassants dans les situations craintes.

Anxiété sociale (phobie sociale). L'agoraphobie doit être différenciée de l'anxiété sociale en se fondant principalement sur les types de situations qui déclenchent la peur, l'anxiété ou l'évitement et sur l'idéation cognitive. Dans l'anxiété sociale, le focus se porte sur la peur d'être jugé négativement.

Trouble panique. Quand les critères pour le trouble panique sont réunis, on ne doit pas faire un diagnostic d'agoraphobie si les comportements d'évitement associés aux attaques de panique ne s'étendent pas à l'évitement de deux situations agoraphobogènes ou plus.

Trouble stress aigu et trouble stress post-traumatique. Le trouble stress aigu et le trouble stress post-traumatique (TSPT) peuvent être différenciés de l'agoraphobie en examinant si la peur, l'anxiété ou l'évitement sont liés exclusivement à des situations qui rappellent à la personne l'événement traumatique. Si la peur, l'anxiété ou l'évitement se limitent aux rappels du traumatisme, et si le comportement d'évitement ne s'étend pas à deux situations agoraphobogènes ou plus, le diagnostic d'agoraphobie ne doit pas être retenu.

Trouble dépressif caractérisé. Dans le trouble dépressif caractérisé, la personne peut éviter de quitter la maison à cause d'une apathie, d'une perte d'énergie, d'une faible estime de soi et d'une anhédonie. Si l'évitement n'est pas lié à des peurs de symptômes de type attaque de panique ou d'autres symptômes invalidants ou embarrassants, l'agoraphobie ne doit pas être diagnostiquée.

Autres affections médicales. On ne fait pas un diagnostic d'agoraphobie si l'évitement de situations est jugé être une conséquence physiologique d'une affection médicale. Cette détermination repose sur les antécédents, les résultats des examens complémentaires et l'examen physique. Les autres affections médicales concernées peuvent inclure les troubles neurodégénératifs avec perturbations motrices associées (p. ex. maladie de Parkinson, sclérose en plaques), ainsi que des troubles cardiovasculaires. Des personnes avec certaines affections médicales peuvent éviter des situations du fait de préoccupations réalistes d'être handicapées (p. ex. évanouissements chez une

personne souffrant d'accidents ischémiques transitoires) ou d'être embarrassées (p. ex. diarrhées chez une personne souffrant de maladie de Crohn). Le diagnostic d'agoraphobie doit être retenu seulement quand la peur ou l'évitement sont clairement excessifs par rapport à ceux habituellement associés à de telles affections médicales.

Comorbidité

La majorité des personnes souffrant d'agoraphobie souffrent aussi d'autres troubles mentaux. Les diagnostics additionnels les plus fréquents sont d'autres troubles anxieux (p. ex. phobies spécifiques, trouble panique, anxiété sociale), les troubles dépressifs (trouble dépressif caractérisé), le trouble stress post-traumatique et le trouble de l'usage d'alcool. Tandis que les autres troubles anxieux (p. ex. anxiété de séparation, phobies spécifiques, trouble panique) précèdent fréquemment la survenue de l'agoraphobie, les troubles dépressifs et les troubles de l'usage d'une substance surviennent typiquement secondairement à l'agoraphobie ([Bittner et al. 2004](#) ; [Reed et Wittchen 1998](#)).

Anxiété généralisée

Critères diagnostiques

300.02 (F41.1)

- A. Anxiété et soucis excessifs (attente avec appréhension) survenant la plupart du temps durant au moins 6 mois concernant un certain nombre d'événements ou d'activités (telles que le travail ou les performances scolaires).
 - B. La personne éprouve de la difficulté à contrôler cette préoccupation.
 - C. L'anxiété et les soucis sont associés à trois (ou plus) des six symptômes suivants (dont au moins certains symptômes ont été présents la plupart du temps durant les 6 derniers mois) :
 - N.B. :** Un seul item est requis chez l'enfant.
 - 1. Agitation ou sensation d'être survolté ou à bout.
 - 2. Fatigabilité.
 - 3. Difficultés de concentration ou trous de mémoire.
 - 4. Irritabilité.
 - 5. Tension musculaire.
 - 6. Perturbation du sommeil (difficultés d'endormissement ou sommeil interrompu ou sommeil agité et non satisfaisant).
 - D. L'anxiété, les soucis ou les symptômes physiques entraînent une détresse ou une altération cliniquement significatives du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.
 - E. La perturbation n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance (p. ex. substance donnant lieu à abus, médicament) ou d'une autre affection médicale (p. ex. hyperthyroïdie).
 - F. La perturbation n'est pas mieux expliquée par un autre trouble mental (p. ex. anxiété ou souci d'avoir une autre attaque de panique dans le trouble panique, évaluation négative dans l'anxiété sociale [phobie sociale], contamination ou autres obsessions dans le trouble obsessionnel-compulsif, séparation des figures d'attachement dans l'anxiété de séparation, souvenirs d'événements traumatiques dans le trouble stress post-traumatique, prise de poids dans l'anorexie mentale, plaintes somatiques dans le trouble à symptomatologie somatique, défauts d'apparence perçus dans l'obsession d'une dysmorphie corporelle, avoir une maladie grave dans la crainte excessive d'avoir une maladie, ou teneur de croyances délirantes dans la schizophrénie ou le trouble délirant).
-

Caractéristiques diagnostiques

La caractéristique essentielle de l'anxiété généralisée est une anxiété et des soucis excessifs (attente avec appréhension) concernant plusieurs événements ou activités. L'intensité, la durée ou la fréquence de l'anxiété et des soucis sont hors de proportions avec la probabilité réelle ou l'impact de l'événement anticipé. Le sujet éprouve de la difficulté à contrôler ses préoccupations et à empêcher les pensées inquiétantes d'interférer avec l'attention portée aux tâches en cours. Les adultes ayant une anxiété généralisée s'inquiètent souvent au sujet des circonstances quotidiennes de la vie de tous les jours comme les responsabilités professionnelles, les problèmes financiers, la santé des membres de la famille, les infortunes de leurs enfants, ou à propos de sujets mineurs (p. ex. les travaux domestiques ou le fait d'être en retard à des rendez-vous). Les enfants ayant une anxiété généralisée ont tendance à s'inquiéter de manière excessive quant à leurs compétences ou à la qualité de leurs performances. Durant l'évolution du trouble, l'objet des soucis peut varier d'une préoccupation à une autre.

Plusieurs caractéristiques distinguent l'anxiété généralisée de l'anxiété non pathologique. Premièrement, les soucis associés à l'anxiété généralisée sont excessifs et interfèrent typiquement de manière significative avec le fonctionnement psychosocial alors que les soucis de la vie quotidienne sont perçus comme plus contrôlables et peuvent être remis à plus tard quand des problèmes plus urgents surviennent. Deuxièmement, les soucis associés à l'anxiété généralisée sont plus envahissants, prononcés, source de détresse, de durée plus longue et surviennent fréquemment sans facteur précipitant. Le diagnostic d'anxiété généralisée est d'autant plus probable que le sujet se fait du souci pour un grand nombre de circonstances de la vie (finances, sécurité des enfants, performances professionnelles). Troisièmement, la probabilité que les soucis quotidiens soient accompagnés de symptômes physiques (p. ex. agitation, sentiment d'être survolté ou à bout) est moindre. Les personnes ayant une anxiété généralisée expriment une détresse subjective due aux soucis constants et à l'altération de leur fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.

L'anxiété et les soucis sont accompagnés d'au moins trois des symptômes supplémentaires suivants : agitation ou sentiment d'être survolté ou à bout, fatigabilité, difficultés de concentration ou trous de mémoire, irritabilité, tension musculaire et perturbation du sommeil, bien qu'un seul symptôme supplémentaire soit requis chez les enfants.

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Outre la tension musculaire, il peut exister des tremblements, des contractions, des sensations de fébrilité et des douleurs ou des endolorissements musculaires. De nombreux sujets ayant une anxiété généralisée ressentent également des symptômes somatiques (p. ex. transpiration, nausée, diarrhée) et une réponse de sursaut exagérée. Des symptômes d'hyperactivité neurovégétative (p. ex. augmentation de la fréquence cardiaque, souffle court, vertiges) sont moins importants dans l'anxiété généralisée que dans les autres troubles anxieux tels que le trouble panique. D'autres affections qui peuvent être associées au stress (syndrome du côlon irritable, céphalées) accompagnent fréquemment l'anxiété généralisée.

Prévalence

La prévalence sur 12 mois de l'anxiété généralisée est de 0,9 % chez les adolescents et de 2,9 % chez les adultes dans la population générale aux États-Unis (Kessler et al. 2012). La prévalence du trouble sur 12 mois dans les autres pays varie entre 0,4 et 3,6 % (Lewis-Fernández et al. 2010). Le taux de morbidité sur la vie entière est de 9,0 % (Kessler et al. 2012). Les femmes ont deux fois plus de risques que les hommes de présenter

une anxiété généralisée (Seedat et al. 2009 ; Vesga-López et al. 2008). La prévalence du diagnostic atteint son maximum à l'âge mur et diminue aux âges avancés de la vie (Gum et al. 2009 ; Kessler et al. 2012).

Les sujets d'origine européenne ont tendance à présenter plus fréquemment une anxiété généralisée que ceux d'origine non européenne (c.-à-d. asiatique, africaine, natifs d'Amérique ou des îles du Pacifique) (Lewis-Fernández et al. 2010). De plus, les habitants des pays développés ont plus tendance que les habitants des pays non développés à signaler des symptômes correspondant aux critères de l'anxiété généralisée au cours de leur vie (Lee et al. 2009).

Développement et évolution

De nombreux sujets ayant une anxiété généralisée rapportent qu'ils se sont sentis anxieux et nerveux toute leur vie. L'âge médian de début de l'anxiété généralisée est de 30 ans ; cependant, l'âge de début s'étend sur un intervalle très large (Kessler et al. 2012). L'âge médian de début est plus élevé que pour les autres troubles anxieux. Les symptômes de soucis et d'anxiété excessifs peuvent survenir plus tôt dans la vie mais se manifestent alors comme un tempérament anxieux (Beesdo et al. 2010). Le trouble apparaît rarement avant l'adolescence (Akiskal 1998 ; Kagan et Snidman 1999). Les symptômes d'anxiété généralisée ont tendance à être chroniques avec des variations durant la vie, fluctuant entre des formes syndromiques et non syndromiques du trouble (Angst et al. 2009 ; Ballenger et al. 2001). Les taux de rémission complète sont très faibles (Bruce et al. 2005 ; Yonkers et al. 2003).

L'expression clinique de l'anxiété généralisée est relativement stable durant la vie. La principale différence entre groupes d'âge concerne le contenu des inquiétudes individuelles. Les enfants et adolescents ont tendance à s'inquiéter plus au sujet de leurs performances scolaires et sportives, alors que les adultes font davantage état de préoccupations pour le bien-être de leur famille ou leur propre santé physique. Ainsi, le contenu des inquiétudes individuelles tend à être congruent avec l'âge. Les adultes jeunes présentent des symptômes plus sévères que les adultes plus âgés (Wolitzky-Taylor et al. 2010).

Plus les symptômes de l'anxiété généralisée apparaissent tôt dans la vie, plus la comorbidité et l'altération du fonctionnement risquent d'être importants (Campbell et al. 2003 ; Le Roux et al. 2005). La survenue d'une affection somatique chronique peut être un sujet d'inquiétude excessive chez les sujets âgés. Chez les personnes âgées fragilisées, les inquiétudes à propos de la santé – et particulièrement la crainte de tomber – peuvent limiter les activités. Chez celles présentant une altération cognitive précoce, les inquiétudes qui pourraient apparaître comme exagérées à l'égard, par exemple, de la localisation précise des choses peuvent être en fait justifiées par l'existence de troubles cognitifs.

Chez les enfants et les adolescents ayant une anxiété généralisée, l'anxiété et les soucis concernent souvent la qualité de leur performance ou leur compétence à l'école ou dans les événements sportifs, même lorsque leur performance n'est pas évaluée par les autres. Ils peuvent avoir des préoccupations excessives concernant la ponctualité. Ils peuvent également être préoccupés par l'idée d'événements catastrophiques tels que des tremblements de terre ou une guerre nucléaire. Les enfants ayant ce trouble peuvent être excessivement conformistes, perfectionnistes et peu sûrs d'eux-mêmes, et ont tendance à refaire les tâches par un manque excessif de satisfaction d'une performance qui n'est pas tout à fait parfaite. Ils sont typiquement trop zélés dans la recherche d'une approbation et requièrent un rassurement excessif vis-à-vis de leur performance et de leurs autres soucis.

Le diagnostic d'anxiété généralisée risque d'être porté de manière excessive chez les enfants. Lorsque ce trouble est évoqué chez les enfants, une évaluation attentive des autres troubles anxieux ou mentaux de l'enfance doit être faite afin de déterminer si les préoccupations ne sont pas mieux expliquées par l'un de ces troubles. L'anxiété de

séparation, l'anxiété sociale (phobie sociale) et le trouble obsessionnel-compulsif sont souvent accompagnés de préoccupations qui peuvent ressembler à celles décrites dans l'anxiété généralisée. Par exemple, un enfant ayant une anxiété sociale peut être préoccupé par ses performances scolaires du fait d'une peur d'être humilié. Les préoccupations concernant la maladie peuvent également être mieux expliquées par l'anxiété de séparation ou le trouble obsessionnel-compulsif.

Facteurs de risque et pronostiques

Tempéramentaux. L'inhibition comportementale, l'affectivité négative (névrosisme) et l'évitement du danger ont été associés à l'anxiété généralisée (Beesdo et al. 2010 ; Green et al. 2010 ; McLaughlin et al. 2010 ; Moffitt et al. 2007).

Environnementaux. Bien que les épreuves vécues dans l'enfance ou l'hyper-protection parentale aient été associées à l'anxiété généralisée (Beesdo et al. 2010 ; Green et al. 2010 ; McLaughlin et al. 2010 ; Moffitt et al. 2007), aucun facteur environnemental n'a été identifié comme spécifique à l'anxiété généralisée ou nécessaire ou suffisant pour poser le diagnostic.

Génétiques et physiologiques. Un tiers du risque de présenter une anxiété généralisée est génétique ; ces facteurs génétiques se chevauchent avec les risques du névrosisme et sont communs aux autres troubles anxieux et de l'humeur, notamment le trouble dépressif caractérisé (Goldberg et al. 2009 ; Hettema et al. 2006).

Questions diagnostiques liées à la culture

Il existe une variation culturelle considérable dans l'expression de l'anxiété généralisée. Par exemple, dans certaines cultures, l'anxiété s'exprime de manière prédominante par des symptômes somatiques, dans d'autres par des symptômes cognitifs. Cette différence peut être plus marquée dans la phase initiale du trouble que plus tard dans l'évolution car le nombre de symptômes augmente avec le temps. Il n'existe pas de données permettant de savoir si la propension à développer des inquiétudes excessives est liée à la culture, même si le thème des soucis peut être spécifique de la culture. Il est important de considérer le contexte social et culturel lorsque l'on évalue le caractère excessif des soucis portant sur certaines situations (Lewis-Fernández et al. 2010).

Questions diagnostiques liées au genre

Dans les services cliniques, le trouble est diagnostiqué un peu plus fréquemment chez les femmes que chez les hommes (environ 55 à 60 % des sujets se présentant avec ce trouble sont des femmes). Dans les études épidémiologiques, la répartition selon le sexe est d'environ deux tiers de femmes pour un tiers d'hommes. Les hommes et les femmes présentant une anxiété généralisée semblent avoir des symptômes similaires mais des profils de comorbidité différents, correspondant aux différences liées au genre dans la prévalence des troubles concernés. Chez les femmes, la comorbidité se limite majoritairement aux troubles anxieux et à la dépression unipolaire, alors que chez les hommes elle a plus tendance à s'étendre aux troubles de l'usage d'une substance (Kramer et al. 2008 ; Vesga-López et al. 2008).

Retentissement fonctionnel de l'anxiété généralisée

Les inquiétudes excessives altèrent les capacités du sujet à faire les choses rapidement et avec efficacité, que ce soit à la maison ou au travail. Les inquiétudes consomment du temps et de l'énergie ; les symptômes associés de tension musculaire, sensation d'être survolté ou à bout, fatigabilité, difficultés de concentration et troubles du sommeil

contribuent à la gêne. Élément important, les inquiétudes excessives des personnes souffrant d'anxiété généralisée peuvent restreindre leurs capacités à favoriser une bonne confiance en soi chez leurs enfants.

L'anxiété généralisée est associée à une gêne et à une détresse significatives indépendamment des troubles comorbides (Kessler et al. 2002a ; Kessler et al. 2002b), et la plupart des adultes ayant le trouble et ne vivant pas en institution sont moyennement à sérieusement invalidés. Aux États-Unis, l'anxiété généralisée est responsable de 110 millions de journées utiles perdues par an (Kessler et al. 2005 ; Merikangas et al. 2007).

Diagnostic différentiel

Trouble anxieux dû à une autre affection médicale. Le diagnostic de trouble anxieux associé à une autre affection médicale doit être porté si l'anxiété et les inquiétudes du sujet sont jugées être, d'après les antécédents, l'examen physique ou les examens complémentaires, la conséquence physiologique directe d'une autre affection médicale spécifique (p. ex. phéochromocytome, hyperthyroïdie).

Trouble anxieux induit par une substance/un médicament. Un trouble anxieux induit par une substance/un médicament se distingue de l'anxiété généralisée par le fait qu'une substance/un médicament (p. ex. substance donnant lieu à abus, exposition à un toxique) est jugée être étiologiquement liée à l'anxiété. Par exemple, une anxiété sévère qui survient uniquement dans le contexte d'une consommation importante de café sera diagnostiquée en tant que trouble anxieux induit par la caféine.

Anxiété sociale. Les sujets ayant une anxiété sociale ont souvent une anxiété anticipatoire focalisée sur les situations sociales à venir dans lesquelles ils doivent réaliser une performance ou être évalués par les autres, alors que les sujets avec une anxiété généralisée s'inquiètent de toute façon, qu'ils soient ou non évalués.

Trouble obsessionnel-compulsif. Plusieurs caractéristiques distinguent les inquiétudes excessives de l'anxiété généralisée des idées obsédantes du trouble obsessionnel-compulsif. Dans l'anxiété généralisée, les inquiétudes portent sur des problèmes qui peuvent survenir, et c'est le caractère excessif de ces inquiétudes à propos d'événements à venir qui est anormal. Dans le trouble obsessionnel-compulsif, les obsessions sont des idées inappropriées qui prennent la forme de pensées, pulsions ou images intrusives et indésirables.

Trouble stress post-traumatique et troubles de l'adaptation. L'anxiété est toujours présente dans le trouble stress post-traumatique. Le diagnostic d'anxiété généralisée ne peut pas être porté si l'anxiété et les inquiétudes sont mieux expliquées par les symptômes d'un trouble stress post-traumatique. L'anxiété peut également exister dans le trouble de l'adaptation mais cette catégorie résiduelle ne peut être utilisée que lorsque les critères d'aucun autre trouble (dont l'anxiété généralisée) ne sont remplis. De plus, dans les troubles de l'adaptation, l'anxiété survient en réaction à un événement stressant dans les 3 mois suivant le début de l'événement et ne persiste pas plus de 6 mois après la fin de l'événement stressant ou de ses conséquences.

Troubles dépressifs, bipolaires et psychotiques. L'anxiété/l'inquiétude généralisée est une caractéristique fréquemment associée aux troubles dépressifs, bipolaires ou psychotiques et ne doit pas être diagnostiquée séparément si l'inquiétude excessive survient uniquement durant l'évolution de ces troubles.

Comorbidité

Les sujets présentant les critères de l'anxiété généralisée ont tendance à remplir ou à avoir rempli les critères d'autres troubles anxieux et de la dépression unipolaire

(Brown et al. 2001 ; Grant et al. 2005 ; Hunt et al. 2002). Le névrosisme ou la labilité émotionnelle qui sous-tendent ces profils de comorbidité sont associés à des antécédents tempéramentaux et à des facteurs de risque génétiques et environnementaux communs à ces troubles (Goldberg et al. 2009 ; Kessler et al. 2011), bien que des voies spécifiques soient aussi possibles (Beesdo et al. 2010 ; Mennin et al. 2008 ; Moffitt et al. 2007). La comorbidité avec des troubles de l'usage d'une substance, des troubles des conduites, des troubles psychotiques, neurodéveloppementaux et neurocognitifs est moins fréquente.

Trouble anxieux induit par une substance/un médicament

Critères diagnostiques

- A. Les attaques de panique ou l'anxiété sont au premier plan du tableau clinique.
- B. Mise en évidence d'après les antécédents, l'examen physique ou les examens complémentaires des deux éléments suivants :
 - 1. Les symptômes du critère A se sont développés durant ou rapidement après une intoxication ou un sevrage d'une substance, ou une exposition à un médicament.
 - 2. La substance ou le médicament concerné est capable de produire les symptômes du critère A.
- C. La perturbation n'est pas mieux expliquée par un trouble anxieux non induit par une substance/un médicament. Des arguments en faveur d'un trouble anxieux indépendant peuvent inclure les points suivants :
 - Les symptômes précèdent le début de l'usage de la substance/du médicament ; les symptômes persistent durant une période de temps substantielle (p. ex. environ un mois) après l'arrêt d'un sevrage aigu ou d'une intoxication grave, ou bien il existe d'autres arguments suggérant l'existence d'un trouble anxieux indépendant non induit par une substance/un médicament (p. ex. des antécédents d'épisodes récurrents non associés à une substance/un médicament).
- D. La perturbation ne survient pas exclusivement au cours d'un état confusionnel.
- E. La perturbation entraîne une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.

N.B. : Ce diagnostic doit être fait plutôt que celui d'intoxication ou de sevrage d'une substance uniquement lorsque les symptômes anxieux du critère A sont au premier plan du tableau clinique et qu'ils sont suffisamment graves pour justifier une attention clinique.

Note de codage : Les codes CIM-9-MC et CIM-10-MC du trouble anxieux induit [par une substance/un médicament spécifique] sont indiqués dans le tableau ci-après. Noter que le code CIM-10-MC dépend du fait qu'il y ait ou non un trouble comorbide de l'usage d'une substance de la même classe. Si un trouble léger de l'usage d'une substance est comorbide avec un trouble anxieux induit par une substance, le 4^e caractère est « 1 », et le clinicien doit enregistrer « trouble de l'usage [d'une substance] léger » avant le trouble anxieux induit par une substance (p. ex. : « trouble léger de l'usage de la cocaïne avec trouble anxieux induit par la cocaïne »). Si un trouble moyen ou grave de l'usage d'une substance est comorbide avec un trouble anxieux induit par une substance, le 4^e caractère est « 2 », et le clinicien doit enregistrer « trouble moyen de l'usage [d'une substance] » ou « trouble grave de l'usage [d'une substance] » en fonction de la sévérité du trouble comorbide de l'usage d'une substance. S'il n'existe pas de trouble comorbide de l'usage d'une substance (p. ex. après une prise unique à forte dose de la substance), le 4^e caractère est « 9 », et le clinicien doit enregistrer seulement le trouble anxieux induit par une substance.

	CIM-9-MC	CIM-10-MC		
		Avec un trouble léger de l'usage d'une substance	Avec un trouble moyen ou grave de l'usage d'une substance	Sans trouble de l'usage d'une substance
Alcool	291.89	F10.180	F10.280	F10.980
Caféine	292.89	F15.180	F15.280	F15.980
Cannabis	292.89	F12.180	F12.280	F12.980
Phencyclidine	292.89	F16.180	F16.280	F16.980
Autre hallucinogène	292.89	F16.180	F16.280	F16.980
Substance inhalée	292.89	F18.180	F18.280	F18.980
Opiacé	292.89	F11.188	F11.288	F11.988
Sédatif, hypnotique ou anxiolytique	292.89	F13.180	F13.280	F13.980
Amphétamine (ou autre stimulant)	292.89	F15.180	F15.280	F15.980
Cocaïne	292.89	F14.180	F14.280	F14.980
Substance autre (ou inconnue)	292.89	F19.180	F19.280	F19.980

Spécifier si (cf. tableau 1 dans le chapitre « Troubles liés à une substance et troubles additifs » pour les diagnostics associés à chaque classe de substance) :

Avec début au cours d'une l'intoxication : Cette spécification s'applique si les critères sont remplis pour une intoxication par la substance et si les symptômes se développent durant l'intoxication.

Avec début au cours d'un sevrage : Cette spécification s'applique si les critères sont remplis pour un sevrage d'une substance et si les symptômes se développent durant, ou peu de temps après le sevrage.

Avec début après la prise d'un médicament : Les symptômes peuvent apparaître soit au début de l'utilisation du médicament, soit après une modification ou un changement d'utilisation.

Procédures d'enregistrement

CIM-9-MC. Le nom du trouble anxieux induit par une substance/un médicament commence par celui de la substance spécifique (p. ex. cocaïne, salbutamol) qui est supposée être la cause des symptômes anxieux. Le code diagnostique est extrait du tableau accompagnant les critères, fondé sur les classes de produits. Pour les substances qui ne correspondent à aucune classe (p. ex. salbutamol), le code « autre substance » doit être appliqué ; et dans les cas où une substance est considérée comme un facteur étiologique mais sans que l'on en connaisse la classe spécifique, la catégorie « substance inconnue » doit être utilisée.

Le nom du trouble est suivi par la caractérisation du mode de début (c.-à-d. début pendant une intoxication, début pendant un sevrage, début pendant l'usage d'un médicament). À la différence de la procédure d'enregistrement de la CIM-10-MC, qui regroupe le trouble induit par une substance et le trouble de l'usage d'une substance dans un même code, la CIM-9-MC attribue un code diagnostique propre au trouble de l'usage d'une substance. Par exemple, dans le cas de symptômes apparaissant lors d'un sevrage

chez un homme ayant un trouble grave de l'usage du lorazépam, le diagnostic est 292.89 trouble anxieux induit par le lorazépam, avec début pendant un sevrage. Un diagnostic additionnel 304.10 trouble grave de l'usage du lorazépam est aussi porté. Quand plus d'une substance sont considérées jouer un rôle significatif dans le développement des symptômes anxieux, chacune doit être listée séparément (p. ex. 292.89 trouble anxieux induit par le méthylphénidate, avec début pendant une intoxication ; 292.89 trouble anxieux induit par le salbutamol, avec début après l'usage du médicament).

CIM-10-MC. Le nom du trouble anxieux induit par une substance/un médicament commence par le nom de la substance (p. ex. cocaïne, salbutamol) qui est présumée causer les symptômes anxieux. Le code diagnostique est extrait du tableau qui suit les critères, fondé sur les classes de produits et sur la présence ou l'absence d'un trouble comorbide de l'usage d'une substance. Pour les substances qui ne correspondent à aucune classe (p. ex. salbutamol), le code « autre substance » doit être appliqué ; et dans les cas où une substance est considérée comme un facteur étiologique mais sans que l'on en connaisse la classe spécifique, la catégorie « substance inconnue » doit être utilisée.

Lors de l'enregistrement du nom du trouble, le trouble comorbide de l'usage d'une substance (le cas échéant) est listé en premier, suivi par le mot « avec », puis par le nom du trouble anxieux induit par une substance, suivi par la caractérisation du mode de début (c.-à-d. début pendant une intoxication, début pendant un sevrage, début lors de l'usage d'un médicament). Par exemple, dans le cas de symptômes apparaissant lors d'un sevrage chez un homme ayant un trouble grave de l'usage du lorazépam, le diagnostic est F13.280 trouble grave de l'usage du lorazépam avec trouble anxieux induit par le lorazépam, avec début pendant un sevrage. Un diagnostic séparé de trouble comorbide grave de l'usage du lorazépam n'est pas porté. Si le trouble anxieux induit par une substance survient sans trouble comorbide de l'usage d'une substance (p. ex. après une seule prise à haute dose de la substance), aucun trouble supplémentaire de l'usage d'une substance n'est noté (p. ex. F16.980 trouble anxieux induit par la psilocybine, avec début pendant une intoxication). Quand plus d'une substance sont considérées jouer un rôle significatif dans le développement des symptômes anxieux, chacune doit être listée séparément (p. ex. F15.280 trouble grave de l'usage du méthylphénidate, avec trouble anxieux induit par le méthylphénidate, avec début pendant une intoxication ; F19.980 trouble anxieux induit par le salbutamol, avec début après l'usage du médicament).

Caractéristiques diagnostiques

Les caractéristiques essentielles d'un trouble anxieux induit par une substance/un médicament sont des symptômes prononcés d'anxiété ou de panique (critère A) que l'on estime être dus aux effets d'une substance (p. ex. substance donnant lieu à abus, médicament ou exposition à un toxique). Les symptômes de panique ou d'anxiété doivent être apparus durant ou rapidement après l'intoxication ou le sevrage d'une substance, ou après l'exposition à un médicament, et les substances ou les médicaments doivent pouvoir produire les symptômes (critère B2). Un trouble anxieux induit par une substance/un médicament dû à un traitement prescrit pour un trouble psychiatrique ou une autre maladie doit avoir débuté pendant la prise du traitement (ou lors du sevrage, si le médicament produit un syndrome de sevrage). Quand le traitement est arrêté, les symptômes de panique ou d'anxiété s'améliorent ou disparaissent en général entre quelques jours et quelques semaines, jusqu'à un mois (en fonction de la demi-vie de la substance/du médicament et de l'existence d'un syndrome de sevrage). Le diagnostic de trouble anxieux induit par une substance/un médicament ne doit pas être posé si le début des symptômes de panique ou d'anxiété précède l'intoxication ou le sevrage de la substance/du médicament, ou si les symptômes persistent sur une

longue période (c.-à-d. habituellement plus d'un mois) après l'intoxication ou le sevrage graves. Si les symptômes de panique ou d'anxiété persistent sur une longue période, d'autres causes doivent être recherchées.

Le diagnostic de trouble anxieux induit par une substance/un médicament doit être posé à la place du diagnostic d'intoxication par une substance ou de sevrage d'une substance seulement quand les symptômes du critère A sont prédominants dans le tableau clinique et sont suffisamment graves pour justifier un examen clinique spécifique.

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Des symptômes de panique ou d'anxiété peuvent survenir en association avec une intoxication par une substance appartenant aux classes de substances suivantes : alcool, caféine, cannabis, phencyclidine, autres hallucinogènes, substances inhalées, stimulants (dont la cocaïne) et autres substances (ou inconnues). Des symptômes de panique ou d'anxiété peuvent survenir en association avec le sevrage d'une substance appartenant aux classes de substances suivantes : alcool, opiacés, sédatifs, hypnotiques et anxiolytiques, stimulants (dont la cocaïne) et autres substances (ou inconnues). Les médicaments qui peuvent provoquer des symptômes anxieux comprennent les anesthésiques et les antalgiques, les sympathomimétiques ou autres bronchodilatateurs, les anticholinergiques, l'insuline, les préparations thyroïdiennes, les contraceptifs oraux, les antihistaminergiques, les antiparkinsoniens, les corticostéroïdes, les antihypertenseurs et médicaments cardiovasculaires, les anticonvulsivants, le carbonate de lithium, les antipsychotiques et les antidépresseurs. Les métaux lourds et les toxiques (p. ex. insecticides organophosphorés, gaz nerveux, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, substances volatiles comme l'essence et la peinture) peuvent également causer des symptômes anxieux ou de panique.

Prévalence

La prévalence du trouble anxieux induit par une substance/un médicament n'est pas bien établie. Des données en population générale suggèrent qu'il doit être rare, avec une prévalence sur 12 mois d'environ 0,002 % ([Grant et al. 2004](#)). Cependant, en populations cliniques, la prévalence est probablement plus élevée.

Marqueurs diagnostiques

Des examens complémentaires (p. ex. toxicologie urinaire) peuvent être utiles pour mesurer le niveau d'intoxication par une substance lors de l'évaluation d'un trouble anxieux induit par une substance/un médicament.

Diagnostic différentiel

Intoxication par une substance et sevrage d'une substance. Des symptômes anxieux surviennent habituellement lors de l'intoxication par une substance et le sevrage d'une substance. Le diagnostic d'intoxication liée à une substance spécifique ou de sevrage d'une substance spécifique suffit habituellement à classer la présentation symptomatique. Un diagnostic de trouble anxieux induit par une substance/un médicament doit être posé en plus de l'intoxication par une substance ou du sevrage d'une substance quand les symptômes de panique ou d'anxiété sont au premier plan du tableau clinique et sont suffisamment graves pour justifier une attention clinique spécifique. Par exemple, les symptômes de panique et d'anxiété sont caractéristiques du sevrage de l'alcool.

Trouble anxieux (c.-à-d. non induit par une substance/un médicament). Un trouble anxieux induit par une substance/un médicament est considéré comme lié étiologiquement à une substance/un médicament. Un trouble anxieux induit par une substance/un médicament se différencie d'un trouble anxieux primaire par le début, l'évolution et d'autres facteurs en rapport avec les substances/médicaments. Pour les substances donnant lieu à abus, il doit y avoir des indices, d'après les antécédents, l'examen somatique ou des examens complémentaires, d'un usage, d'une intoxication ou d'un sevrage. Un trouble anxieux induit par une substance/un médicament survient seulement en association à une intoxication ou à un sevrage, alors que les troubles anxieux primaires peuvent précéder le début de l'usage de substance/médicament. L'existence de caractéristiques atypiques pour un trouble anxieux primaire, comme un âge de début inhabituel (p. ex. début d'un trouble panique après 45 ans) ou des symptômes inhabituels (p. ex. symptômes atypiques d'attaques de panique tels que vrais vertiges, perte d'équilibre, perte de conscience, incontinence urinaire, céphalées, troubles de la déglutition) peuvent faire évoquer une étiologie liée à l'usage de substances/médicaments. Un diagnostic de trouble anxieux primaire est justifié si les symptômes de panique ou d'anxiété persistent sur une longue période (environ un mois ou plus) après la fin de l'intoxication par la substance ou du sevrage aigu, ou s'il existe des antécédents de trouble anxieux.

État confusionnel. Si les symptômes de panique ou d'anxiété surviennent exclusivement durant l'évolution d'un état confusionnel, ils sont considérés comme une caractéristique associée à la confusion et ne sont pas diagnostiqués séparément.

Trouble anxieux dû à une autre affection médicale. Si les symptômes de panique ou d'anxiété sont attribués aux conséquences physiologiques d'une autre affection médicale (c.-à-d. plutôt qu'au médicament pris pour cette affection), un trouble anxieux dû à une autre affection médicale doit être diagnostiqué. Les antécédents donnent souvent des arguments pour cette évaluation. Parfois, un changement du traitement de l'autre affection médicale (p. ex. arrêt ou substitution du médicament) peut être nécessaire pour déterminer si le médicament est l'agent causal (auquel cas les symptômes seraient mieux expliqués par un trouble anxieux induit par une substance/un médicament). Si les troubles sont imputables à la fois à une autre affection médicale et à l'usage d'une substance, les deux diagnostics (c.-à-d. trouble anxieux dû à une autre affection médicale et trouble anxieux induit par une substance/un médicament) peuvent être posés. S'il manque des arguments pour pouvoir déterminer si les symptômes de panique et d'anxiété sont imputables à une substance/un médicament ou à une autre affection médicale ou sont primaires (c.-à-d. non imputables à une substance ou à une autre affection médicale), un diagnostic d'autre trouble anxieux spécifié ou de trouble anxieux non spécifié peut être posé.

Trouble anxieux dû à une autre affection médicale

Critères diagnostiques

293.84 (F06.4)

- A. Les attaques de panique ou l'anxiété sont au premier plan du tableau clinique.
- B. Les antécédents, l'examen physique ou les examens complémentaires montrent que la perturbation est la conséquence physiologique directe d'une autre affection médicale.
- C. La perturbation n'est pas mieux expliquée par un autre trouble mental.

- D. La perturbation ne survient pas exclusivement au cours d'un état confusionnel.
- E. La perturbation entraîne une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.

Note de codage : Inclure le nom de l'autre affection médicale dans le nom du trouble mental (p. ex. 293.84 [F06.4] trouble anxieux dû à un phéochromocytome). L'autre affection médicale doit être codée et notée séparément immédiatement avant le trouble anxieux dû à l'affection médicale (p. ex. 227.0 [D35.00] phéochromocytome ; 293.84 [F06.4] trouble anxieux dû à un phéochromocytome).

Caractéristiques diagnostiques

La caractéristique essentielle du trouble anxieux dû à une autre affection médicale est une anxiété cliniquement significative que l'on considère comme un effet physiologique d'une autre affection médicale. Les symptômes peuvent comprendre des symptômes marqués d'anxiété ou des attaques de panique (critère A). Les antécédents, l'examen physique ou les examens complémentaires doivent permettre de confirmer que les symptômes sont bien expliqués par l'affection physique associée (critère B). De plus, il faut s'assurer que les symptômes ne sont pas mieux expliqués par un autre trouble mental, en particulier un trouble de l'adaptation avec anxiété, dans lequel une affection médicale constituerait le facteur de stress (critère C). Dans ce cas, un sujet ayant un trouble de l'adaptation est surtout inquiet à propos de l'importance et des conséquences de l'affection médicale associée. À l'inverse, il existe souvent une prédominance de symptômes physiques d'anxiété (p. ex. un souffle court) quand l'anxiété est due à une autre affection médicale. Le diagnostic ne peut pas être posé si les symptômes anxieux ne surviennent qu'au cours d'un état confusionnel (critère D). Les symptômes anxieux doivent causer une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants (critère E).

Pour déterminer si les symptômes anxieux sont dus à une autre affection médicale, le clinicien doit tout d'abord établir la présence d'une affection médicale. Ensuite, il doit établir que les symptômes anxieux sont étiologiquement liés à l'affection médicale par un mécanisme physiologique, avant de décider qu'il s'agit bien de la meilleure explication des symptômes du patient. Une évaluation soigneuse et détaillée de nombreux facteurs est nécessaire pour porter ce jugement. Plusieurs aspects du tableau clinique peuvent être pris en compte : 1) la présence d'une association temporelle claire entre le début, l'exacerbation ou la rémission de l'affection médicale et les symptômes anxieux ; 2) la présence de caractéristiques atypiques pour un trouble anxieux primaire (p. ex. âge de début ou évolution inhabituels) ; et 3) des données de la littérature confirmant qu'un mécanisme physiologique connu (p. ex. hyperthyroïdie) cause l'anxiété. De plus, la perturbation ne doit pas être mieux expliquée par un trouble anxieux primaire, un trouble anxieux induit par une substance/un médicament ou un autre trouble mental primaire (p. ex. trouble de l'adaptation).

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Un nombre important d'affections médicales sont connues pour compter l'anxiété parmi leurs symptômes. Des exemples comprennent des maladies endocriniennes (p. ex. hyperthyroïdie, phéochromocytome, hypoglycémie, hyperadrénocorticisme), des affections cardiovasculaires (p. ex. insuffisance cardiaque, embolie pulmonaire,

arythmie telle la fibrillation auriculaire), des affections respiratoires (p. ex. broncho-pneumopathie chronique obstructive, asthme, pneumonie), des affections métaboliques (p. ex. déficit en vitamine B12, porphyrie) et des affections neurologiques (p. ex. tumeurs, dysfonction vestibulaire, encéphalite, épilepsie). L'anxiété due à une autre affection médicale est diagnostiquée quand l'affection médicale est connue pour induire de l'anxiété et quand elle précède le début de l'anxiété.

Prévalence

La prévalence du trouble anxieux dû à une autre affection médicale n'est pas clairement établie. Elle semble élevée chez les sujets ayant diverses affections médicales, dont l'asthme, l'hypertension, les ulcères et l'arthrose (Kessler et al. 2003). Cependant, cette prévalence élevée peut être due à d'autres raisons qu'un lien de causalité direct entre l'affection médicale et l'anxiété.

Développement et évolution

Le développement et l'évolution du trouble anxieux dû à une autre affection médicale suivent généralement l'évolution de la maladie sous-jacente. Ce diagnostic n'est pas censé inclure les cas de troubles anxieux primaires survenant dans un contexte de maladie somatique chronique. Cela est important à prendre en compte chez les sujets âgés, qui peuvent présenter une maladie somatique chronique et ensuite développer un trouble anxieux.

Marqueurs diagnostiques

Des examens complémentaires et/ou des examens physiques sont nécessaires pour confirmer le diagnostic d'affection médicale associée.

Diagnostic différentiel

Syndrome confusionnel. Un diagnostic séparé de trouble anxieux dû à une autre affection médicale ne peut pas être posé si la perturbation anxieuse survient exclusivement durant l'évolution d'un état confusionnel. Cependant, un diagnostic de trouble anxieux dû à une autre affection médicale peut être posé en plus d'un diagnostic de trouble neurocognitif majeur (démence) si l'étiologie de l'anxiété est considérée comme une conséquence physiologique du processus pathologique causant le trouble neurocognitif et si l'anxiété est une composante prédominante du tableau clinique.

Présentation symptomatique mixte (p. ex. humeur et anxiété). Si le tableau clinique inclut un mélange de différents types de symptômes, le trouble mental spécifique dû à une autre affection médicale dépend des symptômes prédominants.

Trouble anxieux induit par une substance/un médicament. S'il existe des preuves d'un usage récent et prolongé d'une substance (dont des médicaments ayant des effets psychoactifs), d'un sevrage ou de l'exposition à un toxique, un trouble anxieux induit par une substance/un médicament peut être considéré. Certains médicaments sont connus pour leur capacité à augmenter l'anxiété (p. ex. corticostéroïdes, œstrogènes et métoclopramide), et quand c'est le cas, le médicament peut être l'étiologie la plus probable, bien qu'il puisse être difficile de déterminer si l'anxiété est imputable aux médicaments ou à l'affection médicale elle-même. Quand un diagnostic d'anxiété induite par une substance est posé en relation avec une substance récréative ou non prescrite, il peut être utile de réaliser une recherche de toxique urinaire ou sanguine

ou un autre examen complémentaire. La survenue de symptômes pendant ou peu de temps après (c.-à-d. durant les 4 semaines suivantes) une intoxication ou un sevrage ou après la prise d'un traitement peut être un indice important en faveur d'un trouble anxieux induit par une substance/un médicament, selon le type, la durée ou la quantité de substance consommée. Si le trouble est associé à la fois avec une autre affection médicale et avec un usage de substance, les deux diagnostics (c.-à-d. trouble anxieux dû à une autre affection médicale et trouble anxieux induit par une substance/un médicament) peuvent être posés. Des caractéristiques comme un début après l'âge de 45 ans ou la présence de symptômes atypiques lors des attaques de panique (p. ex. vertiges, perte de connaissance, perte du contrôle de la vessie ou des intestins, troubles d'élocution, amnésie) suggèrent la possibilité qu'une autre affection médicale ou qu'une substance peut causer les symptômes d'attaque de panique.

Trouble anxieux (non dû à une affection médicale connue). Un trouble anxieux dû à une autre affection médicale doit être différencié d'un autre trouble anxieux (et notamment le trouble panique et l'anxiété généralisée). Dans les autres troubles anxieux, aucun mécanisme physiologique spécifique ayant un lien de causalité directe avec l'autre affection médicale ne peut être démontré. Un âge tardif de début, des symptômes atypiques et l'absence d'antécédents personnels ou familiaux suggèrent la nécessité d'une évaluation minutieuse pour éliminer le diagnostic de trouble anxieux dû à une autre affection médicale. Un trouble anxieux peut aggraver ou augmenter le risque d'une maladie somatique comme des événements cardiovasculaires et l'infarctus du myocarde et ne doit pas être diagnostiqué alors comme un trouble anxieux dû à une autre affection médicale (Chen et al. 2009 ; Martens et al. 2010 ; Scherrer et al. 2010).

Crainte excessive d'avoir une maladie. Un trouble anxieux dû à une autre affection médicale doit être différencié de la crainte excessive d'avoir une maladie. La crainte excessive d'avoir une maladie est caractérisée par une inquiétude à l'égard des maladies, des soucis par rapport à la douleur et des préoccupations corporelles. Dans le cas de la crainte excessive d'avoir une maladie, les sujets peuvent avoir ou non des affections médicales diagnostiquées. Bien qu'un individu ayant une crainte excessive d'avoir une maladie et une affection médicale diagnostiquée ait un risque de présenter une anxiété à propos de son affection médicale, cette dernière n'est pas reliée physiologiquement aux symptômes anxieux.

Troubles de l'adaptation. Un trouble anxieux dû à une autre affection médicale doit être différencié d'un trouble de l'adaptation avec anxiété, ou avec anxiété et humeur dépressive. Un trouble de l'adaptation peut être évoqué quand les sujets présentent une réaction inadaptée au stress lié au fait d'avoir une autre affection médicale. La réaction au stress dépend habituellement de l'importance et des conséquences du stress, à la différence des symptômes anxieux et thymiques qui surviennent comme des conséquences physiologiques d'une autre affection médicale. Dans le trouble de l'adaptation, les symptômes anxieux sont typiquement une manière de faire face au stress d'avoir une affection médicale, alors que dans un trouble anxieux dû à une autre affection médicale, les sujets ont plus tendance à présenter des symptômes physiques prédominants et à se focaliser sur d'autres problèmes que le stress lié à la maladie.

Caractéristiques associées à un autre trouble mental. Des symptômes anxieux peuvent être des caractéristiques associées à un autre trouble mental (p. ex. schizophrénie, anorexie mentale).

Autre trouble anxieux spécifié ou non spécifié. Ce diagnostic peut être posé quand il est impossible d'établir si les symptômes anxieux sont primaires, induits par une substance ou associés à une autre affection médicale.

Autre trouble anxieux spécifié

300.09 (F41.8)

Cette catégorie s'applique aux présentations cliniques dans lesquelles les symptômes caractéristiques d'un trouble anxieux entraînant une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants prédominent mais ne remplissent complètement les critères d'aucun trouble de la classe des troubles anxieux. La catégorie autre trouble anxieux spécifié est utilisée pour les situations dans lesquelles le clinicien choisit de préciser la raison particulière pour laquelle la présentation clinique ne répond pas à un trouble anxieux spécifique. Cela se fait en notant « autre trouble anxieux spécifié » puis la raison spécifique (p. ex. « l'anxiété généralisée n'est pas présente au moins la moitié du temps »).

Exemples de présentations cliniques qui peuvent être spécifiées en utilisant l'expression « autre trouble spécifié » :

1. **Attaques de panique paucisymptomatiques.**
2. **Anxiété généralisée ne survenant pas au moins la moitié du temps.**
3. **Khyâl cap (attaques de vent) :** Cf. « Glossaire des concepts culturels de détresse » en annexe.
4. **Ataque de nervios (attaque de nerfs) :** Cf. « Glossaire des concepts culturels de détresse » en annexe.

Trouble anxieux non spécifié

300.00 (F41.9)

Cette catégorie s'applique aux présentations cliniques dans lesquelles les symptômes caractéristiques d'un trouble anxieux entraînant une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants prédominent mais ne remplissent complètement les critères d'aucun trouble de la classe des troubles anxieux. La catégorie trouble anxieux non spécifié est utilisée pour les situations dans lesquelles le clinicien choisit de *ne pas* préciser la raison particulière pour laquelle la présentation clinique ne répond pas à un trouble anxieux spécifique, et comprend les présentations cliniques dans lesquelles les informations sont insuffisantes pour poser un diagnostic spécifique (p. ex. aux urgences).

Références

Anxiété de séparation

- Allan JL, Lavalley KL, Herren C, et al: DSM-IV criteria for childhood separation anxiety disorder: informant, age, and sex differences. *J Anxiety Disord* 24(8):946–952, 2010 20675099
- Bögels SM, Knappe S, Clark LA: Separation anxiety disorder in adults in DSM-V. Submitted for publication.
- Bolton D, Eley TC, O'Connor TG, et al: Prevalence and genetic and environmental influences on anxiety disorders in 6-year-old twins. *Psychol Med* 36(3):335–344, 2006 16288680
- Cartwright-Hatton S, McNicol K, Doubleday E: Anxiety in a neglected population: prevalence of anxiety disorders in pre-adolescent children. *Clin Psychol Rev* 26(7):817–833, 2006 16517038

- Gould MS, King R, Greenwald S, et al: Psychopathology associated with suicidal ideation and attempts among children and adolescents. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 37(9):915–923, 1998 9735611
- Kessler RC, Berglund P, Demler O, et al: Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. *Arch Gen Psychiatry* 62(6):593–602, 2005 15939837
- Kessler RC, Petukhova M, Samson NA, et al: Twelve-month and lifetime prevalence and lifetime morbid risk of anxiety and mood disorders in the United States. *Int J Methods Psychiatr Res* 21(3):169–184, 2012 22865617 10.1002/MPR.1359
- Loas G, Atger F, Perdereau F, et al: Comorbidity of dependent personality disorder and separation anxiety disorder in addictive disorders and in healthy subjects. *Psychopathology* 35(4):249–253, 2002 12239442
- Manicavasagar V, Silove D, Wagner R, Hadzi-Pavlovic D: Parental representations associated with adult separation anxiety and panic disorder-agoraphobia. *Aust N Z J Psychiatry* 33(3):422–428, 1999 10442800
- Manicavasagar V, Silove D, Curtis J, Wagner R: Continuities of separation anxiety from early life into adulthood. *J Anxiety Disord* 14(1):1–18, 2000 10770232
- Pine DS, Klein RG: Anxiety disorder, in Rutter's Child and Adolescent Psychiatry, 5th Edition. Edited by Rutter M, Bishop D, Pine D, et al. London, Blackwell, 2008, 628–648.
- Pine DS, Klein RG, Coplan JD, et al: Differential carbon dioxide sensitivity in childhood anxiety disorders and nonill comparison group. *Arch Gen Psychiatry* 57(10):960–967, 2000 11015814
- Roberson-Nay R, Klein DF, Klein RG, et al: Carbon dioxide hypersensitivity in separation-anxious offspring of parents with panic disorder. *Biol Psychiatry* 67(12):1171–1177, 2010 20172505
- Shear K, Jin R, Ruscio AM, et al: Prevalence and correlates of estimated DSM-IV child and adult separation anxiety disorder in the National Comorbidity Survey Replication. *Am J Psychiatry* 163(6):1074–1083, 2006 16741209
- Verduin TL, Kendall PC: Differential occurrence of comorbidity within childhood anxiety disorders. *J Clin Child Adolesc Psychol* 32(2):290–295, 2003 12679288
- Wood JJ: Parental intrusiveness and children's separation anxiety in a clinical sample. *Child Psychiatry Hum Dev* 37(1):73–87, 2007 16932853

Mutisme sélectif

- Carbone D, Schmidt LA, Cunningham CC, et al: Behavioral and socio-emotional functioning in children with selective mutism: a comparison with anxious and typically developing children across multiple informants. *J Abnorm Child Psychol* 38(8):1057–1067, 2010 20496108
- Chavira DA, Shipon-Blum E, Hitchcock C, et al: Selective mutism and social anxiety disorder: all in the family? *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 46(11):1464–1472, 2007 18049296
- Cohan SL, Chavira DA, Shipon-Blum E, et al: Refining the classification of children with selective mutism: a latent profile analysis. *J Clin Child. Adolesc Psychol* 37(4):770–784, 2008 18991128
- Edison SC, Evans MA, McHolm AE, et al: An investigation of control among parents of selectively mute, anxious, and non-anxious children. *Child Psychiatry Hum Dev* 42(3):270–290, 2011 21161368
- Carbone D, Schmidt LA, Cunningham CC, et al: Behavioral and socio-emotional functioning in children with selective mutism: a comparison with anxious and typically developing children across multiple informants. *J Abnorm Child Psychol* 38(8):1057–1067, 2010 20496108
- Chavira DA, Shipon-Blum E, Hitchcock C, et al: Selective mutism and social anxiety disorder: all in the family? *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 46(11):1464–1472, 2007 18049296
- Cohan SL, Chavira DA, Shipon-Blum E, et al: Refining the classification of children with selective mutism: a latent profile analysis. *J Clin Child. Adolesc Psychol* 37(4):770–784, 2008 18991128
- Edison SC, Evans MA, McHolm AE, et al: An investigation of control among parents of selectively mute, anxious, and non-anxious children. *Child Psychiatry Hum Dev* 42(3):270–290, 2011 21161368
- Manassis K, Tannock R, Garland EJ, et al: The sounds of silence: language, cognition, and anxiety in selective mutism. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 46(9):1187–1195, 2007 17712242
- Nowakowski ME, Cunningham CC, McHolm AE, et al: Language and academic abilities in children with selective mutism. *Infant Child Dev* 18:271–290, 2009
- Remschmidt H, Poller M, Herpertz-Dahlmann B, et al: A follow-up study of 45 patients with selective mutism. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci* 251(6):284–296, 2001 11881843
- Viana AG, Beidel DC, Rabian B: Selective mutism: a review and integration of the last 15 years. *Clin Psychol Rev* 29(1):57–67, 2009 18986742